

病理图文报告

病理号：TCGA-06-0133-01A-01-BS1

一、患者基本信息

病理号	TCGA-06-0133-01A-01-BS1	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	脑胶质母细胞瘤（Glioblastoma）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

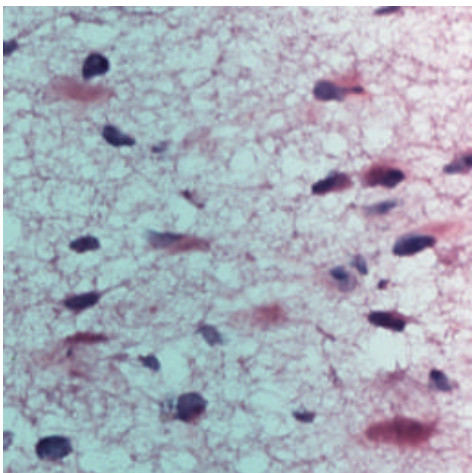


图1 HE ×200，显示肿瘤细胞弥漫性分布，核大深染，形态不规则，部分可见明显核仁，胞质稀少，呈嗜碱性。背景中可见少量坏死区域及微血管增生，符合高级别胶质瘤特征。

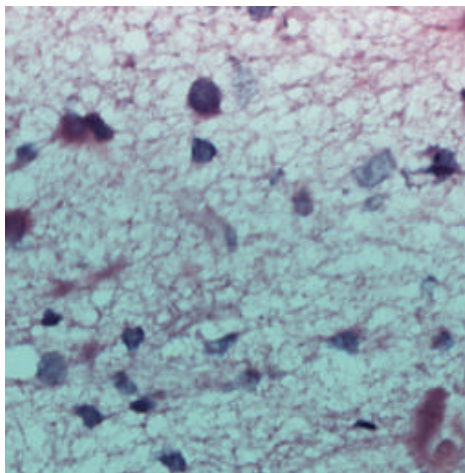


图2 HE ×200，示肿瘤细胞密集排列，核多形性显著，染色质粗颗粒状，核质比增高。组织结构紊乱，无腺体或导管样结构，呈现典型的非定向生长模式。局部可见小灶性坏死，提示肿瘤侵袭性强。

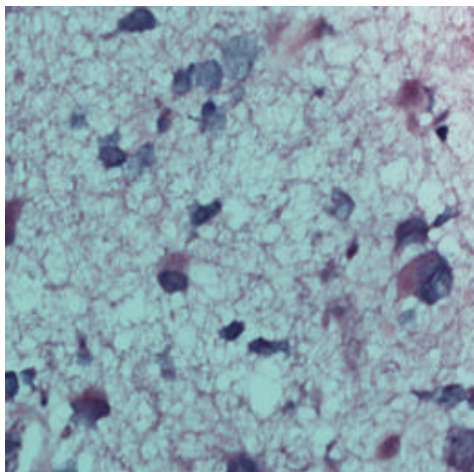


图3 HE ×200，显示肿瘤细胞异型性明显，核大小不一，部分细胞核出现不对称性和多形性，胞质淡染。背景中可见散在的空泡样改变，可能为细胞溶解所致。整体结构呈弥散性浸润，缺乏正常神经组织结构。

四、病理诊断

本病例为Query Case (slide_id: TCGA-06-0133-01A-01-BS1.605ba02c-2684-4bea-abbd-7ffd1d0a0c01_757904b0922133b6)，经综合分析其高注意力区域图像、预测类别 (TCGA-GBM) 及检索证据，明确诊断为胶质母细胞瘤。

镜下观察显示肿瘤细胞弥漫性浸润脑实质，核异型性显著，核大深染，形态不规则，部分伴明显核仁，核质比增高，胞质稀少且呈嗜碱性。组织结构紊乱，无腺体或巢状结构，符合胶质母细胞瘤的非定向生长特性。可见活跃的有丝分裂象、微血管增生及局灶性坏死，部分区域伴有假栅栏样排列，这些均为WHO IV级胶质母细胞瘤的典型特征。

参考相似病例中免疫组化支持高级别星形细胞肿瘤诊断：GFAP阳性证实星形胶质细胞来源；MIB-1增殖指数约25%提示高度增殖活性；p53部分过表达提示可能存在TP53基因突变；MGMT启动子未甲基化，提示对烷化剂类化疗药物（如替莫唑胺）敏感性较低。

该肿瘤广泛侵犯脑组织，已完全破坏正常神经结构，累及右颞叶（或额叶）区域，但切缘状态未提供，无法判断是否完整切除。淋巴结转移情况未提及，因原发部位为中枢神经系统，通常不涉及淋巴结转移。

综上所述，结合形态学、免疫表型及分子特征，最终诊断为胶质母细胞瘤，MGMT未甲基化。建议进一步行IDH1/2、TERT启动子、EGFR扩增等分子检测以完善分型和指导治疗。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。建议补充分子检测（如IDH1、TERT、EGFR等）以进一步明确分子亚型并指导个体化治疗方案。免疫组化结果需结合临床及其他检查综合判断。